

Lucio Cottini

L'autodeterminazione nelle persone con disabilità

Percorsi educativi per svilupparla

leGUIDE

Erickson



Autodeterminazione, qualità della vita e capability approach

Savater, un importante filosofo spagnolo al quale si è fatto cenno anche nell'introduzione, in un suo saggio dal titolo *Il coraggio di scegliere*, sostiene che l'uomo è un essere prassico, ovvero un essere che agisce, che vuol fare delle cose e che fa le cose che vuole fare (Savater, 2004). Agire, nella sua interpretazione, non significa soltanto attivarsi per soddisfare una spinta istintuale, ma portare a compimento un progetto personale: l'essere umano dispone di una programmazione di base, biologica, in quanto essere vivente, ma come umano è chiamato ad autoprogrammarsi e ad autodeterminarsi. La dignità di ogni persona, quindi, risiede nell'essere in grado di guidare la propria azione in riferimento a una serie di opzioni.

Questa spinta all'agire autodeterminato caratterizza tutti gli individui, indipendentemente dalle loro abilità e competenze, ed è una delle condizioni di base su cui si fonda la qualità stessa della vita di ognuno. Il motore dell'azione umana, quindi, risiede sostanzialmente nella possibilità e capacità di scelta, coniugando adeguatamente conoscenza, immaginazione e decisione nel campo del possibile.

È evidente come, alla luce di queste premesse, l'educazione alla libertà e all'agire debba necessariamente considerare la dimensione dell'autodeterminazione, anche nel momento in cui le persone presentano disabilità importanti con scarsi livelli di autonomia personale; situazione questa che può alimentare l'equivoco e accreditare la convinzione che si possa decidere per gli altri.

L'essere incapaci di fare da soli alcune cose non fa venire meno la possibilità di incidere sul proprio ambiente per orientarlo nella direzione delle scelte personali, chiaramente limitate, come per tutti, all'ambito delle condizioni effettivamente autodeterminabili.

In questo capitolo introduco il costrutto dell'autodeterminazione, evidenziandone le dimensioni che lo caratterizzano e che ne fanno un modello di riferimento anche per la pedagogia e la didattica speciale. Oltre ciò, cercherò di analizzare lo stretto legame che esiste fra autodeterminazione e qualità della vita e mi soffermerò a descrivere l'approccio delle capacità (*capability approach*), nel quale l'espansione delle opportunità di scelta, e quindi delle libertà delle persone, è posta a fondamento del concetto di «star bene» (*well-being*; Sen, 1993).

Il costrutto dell'autodeterminazione

Una delle prime definizioni di autodeterminazione come concetto specifico nell'ambito dell'educazione è stata fornita da Deci e Ryan, i quali l'hanno identificata come «la capacità di scegliere fra varie opportunità e di impiegare quelle scelte per determinare le proprie azioni personali. [...] Le persone hanno una naturale propensione a svilupparsi psicologicamente, a adoperarsi per superare autonomamente le sfide dell'ambiente, a mettere in atto comportamenti autodeterminati» (Deci e Ryan, 1985, p. 38). L'autodeterminazione, quindi, prima ancora di essere una capacità è una necessità, che per essere raggiunta richiede non soltanto una serie di competenze della persona, ma anche un contesto favorevole e una serie di supporti sociali (Deci e Ryan 1985; Ryan e Deci, 2000).

Ward (1992) ritiene che l'autodeterminazione sia un obiettivo cruciale per gli individui, specie nel momento in cui essi arrivano all'età adulta. Egli evidenzia come l'autodeterminazione sia il risultato degli atteggiamenti che consentono agli individui di definire i propri obiettivi e delle abilità che permettono di conseguirli. Gli elementi di fondo di questa progressiva costruzione sono l'autorealizzazione, l'assertività, la creatività, la considerazione positiva di sé e la capacità di autotutelarsi.

Sulla stessa lunghezza d'onda, Hoffman e Field (1995, p. 136), definiscono l'autodeterminazione come «l'abilità personale per individuare e ottenere obiettivi, fondata su una conoscenza e una valorizzazione di se stessi». Essi dichiarano, inoltre, che l'autodeterminazione è «promossa o scoraggiata da alcuni fattori che sono sotto il controllo dell'individuo (valori,

meno la possibilità
ezione delle scelte
o delle condizioni

eterminazione, evi-
anno un modello di
Oltre ciò, cercherò
zione e qualità della
à (capability appro-
quindi delle libertà
bene» (*well-being*;

one come concetto
Deci e Ryan, i quali
arie opportunità e di
i personali. [...] Le
psicologicamente, a
mbiente, a mettere in
1985, p. 38). L'auto-
acità è una necessità,
di competenze della
supporti sociali (Deci

un obiettivo cruciale
no all'età adulta. Egli
gli atteggiamenti che
e delle abilità che per-
rogressiva costruzione
nsiderazione positiva

(1995, p. 136), defi-
niale per individuare
a valorizzazione di se
zione è «promossa o
dell'individuo (valori,

conoscenze, abilità) e da altre variabili connesse invece al contesto naturale (opportunità di fare scelte, atteggiamenti da parte degli altri)» (Hoffman e Field, 1995, p. 140).

L'autodeterminazione, quindi, è da intendersi come un costrutto multi-dimensionale. Mithaug e colleghi (1998), a questo proposito, la descrivono come caratterizzata da una serie di abilità attraverso le quali le persone:

- conoscono ed esprimono i propri interessi, bisogni e capacità;
- stabiliscono le proprie aspettative e i propri obiettivi, al fine di soddisfare tali interessi e bisogni;
- scelgono, decidono, progettano;
- agiscono per portare a termine i propri progetti;
- valutano le conseguenze delle proprie azioni;
- modificano azioni e progetti al fine di raggiungere i propri obiettivi in modo efficace.

È immediatamente evidente come le persone con disabilità intellettiva e con autismo, delle quali si tratta in maniera particolare in questo lavoro, siano meno preparate per affrontare i diversi aspetti di questo processo.

Un contributo davvero rilevante alla definizione del costrutto di autodeterminazione e alla sua promozione come concetto centrale nella prospettiva della qualità della vita delle persone con disabilità è stato fornito all'interno del gruppo coordinato da Wehmeyer. In vari contributi questi autori (Wehmeyer e Metzler, 1995; Wehmeyer, Kelchner e Richards, 1996; Wehmeyer e Schwartz, 1997; Wehmeyer et al., 1998; Wehmeyer, 1999; Wehmeyer e Garner, 2003) hanno affermato che un individuo è dotato di autodeterminazione quando agisce come *agente causale primario* della propria vita e quando le sue decisioni relative al proprio benessere sono libere da condizionamenti o da influenze esterne. Il concetto di *agente causale* è centrale in questa prospettiva teorica e si riferisce al fatto che la persona mette in atto delle azioni o ha comunque la forza e l'autorità per farlo, al fine di incidere su alcuni aspetti della propria vita. La persona autodeterminata, in altri termini, agisce come un agente causale con l'intento di strutturare il proprio futuro e il proprio destino.

A seguito di numerose ricerche che hanno preso in considerazione persone di età diverse a sviluppo tipico, con disturbi di apprendimento e con disabilità intellettiva, Wehmeyer e colleghi hanno tentato di specificare in maniera operativa il costrutto di autodeterminazione, proponendo uno specifico modello di riferimento. Come illustra la figura 1.1, in tale modello sono considerate sia la dimensione individuale — cioè le competenze necessarie alla persona per assumere condotte orientate nel senso dell'autodeterminazione — che quella

ambientale, la quale si concretizza nelle opportunità fornite dal contesto per assumere il ruolo di agente causale nella propria esistenza. Da questo quadro di riferimento appare immediatamente evidente come la situazione si presenti complessa per le persone con disabilità, le quali oltre ad avere un carente repertorio di competenze in grado di favorire condotte autodeterminate, si devono spesso relazionare con un ambiente orientato a vicariare decisioni, anche quelle più comuni relative alla vita di ogni giorno.

Altro aspetto di fondamentale importanza che il modello mette opportunamente in evidenza è il rilievo dato al ruolo dei sostegni, che enfatizza la dimensione educativa in tutto il ciclo di vita della persona, specie se in situazione di disabilità. Le componenti dell'autodeterminazione, in altri termini, devono essere considerate nei percorsi didattici e riabilitativi in ogni età e non soltanto in particolari momenti dell'esistenza che sembrano maggiormente associati a processi decisionali (ad esempio: transizione scuola-lavoro, scelta delle condizioni abitative, ecc.) (si veda la figura 1.1).

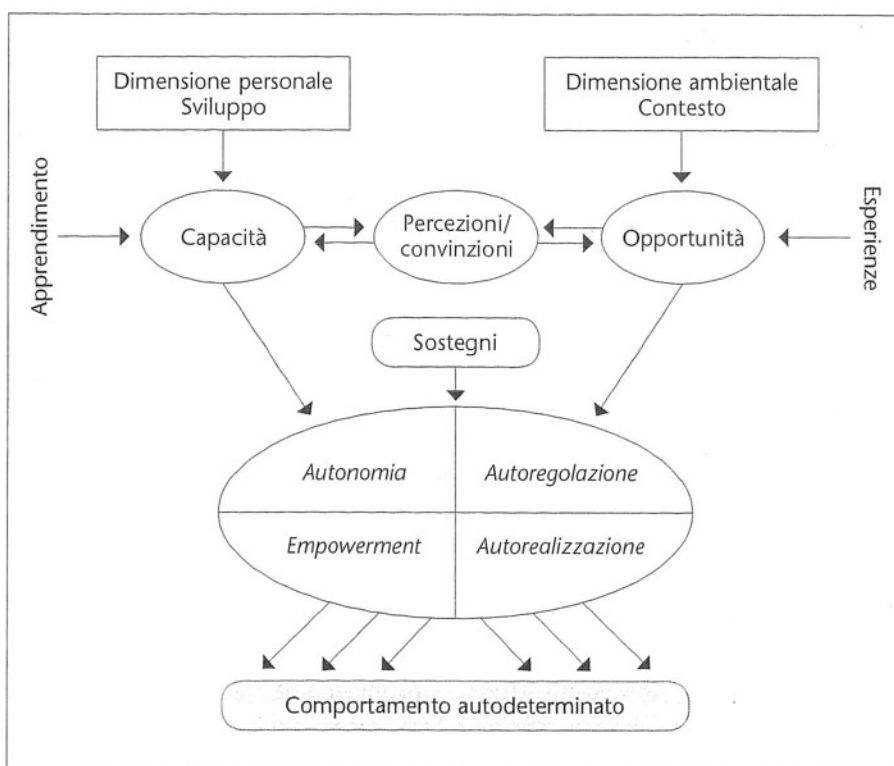


Fig. 1.1 Modello funzionale di autodeterminazione (Wehmeyer 1999; Wehmeyer et al., 2003).

Facend
autodeterm

1. *autonomi*
persona
Come so
prevede
riguarda
L'esito di
termini, l
2. *autoregol*
(autoistru
consegui
può cons
propria v
3. *empower*
interno e
queste co
personali
4. *autorealiz*
dividuo, c
comprens
ambiente,
l'individu
mento (S

Queste
determinato,

- capacità di
- capacità di
- capacità di
- capacità di
- capacità di
- capacità di
- percezione

In sinte
fornite tend
complement
nell'individu
persona con d

Facendo riferimento a questa impostazione funzionale, il costrutto di autodeterminazione viene articolato in quattro componenti fondamentali:

1. *autonomia*, che include il livello di indipendenza, nonché la capacità della persona di agire sulla base di un proprio sistema di valori e di interessi. Come sostengono Sigafos e colleghi (1988, p. 432), lo sviluppo umano prevede una progressione «a partire dalla dipendenza dagli altri per quanto riguarda le cure, fino ad arrivare alla cura di sé e all'autonomia decisionale». L'esito di questa progressione è il funzionamento autonomo o, detto in altri termini, l'autonomia comportamentale;
2. *autoregolazione*, che comprende essenzialmente abilità di autogestione (autoistruzione, automonitoraggio e autorinforzamento), la definizione e il conseguimento di obiettivi, il problem solving. Ciascuna di queste strategie può consentire alla persona di acquisire un controllo più adeguato sulla propria vita;
3. *empowerment psicologico*, che si concretizza soprattutto in un *locus of control* interno e in adeguati livelli di autoefficacia. La persona, quando possiede queste competenze, riferisce i risultati delle proprie azioni a componenti personali e ha fiducia nelle proprie possibilità di successo;
4. *autorealizzazione*, che è relativa al grado di autoconsapevolezza dell'individuo, dei propri punti di forza e dei limiti. Questa conoscenza di sé e comprensione si forma con l'esperienza e l'interpretazione del proprio ambiente, è influenzata dalle valutazioni delle altre persone significative per l'individuo, dai rinforzi e dalle attribuzioni causali del proprio comportamento (Schalock e Verdugo Alonso, 2002).

Queste dimensioni essenziali prendono forma nel comportamento autodeterminato, che si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi:

- capacità di scegliere;
- capacità di problem solving;
- capacità di prendere decisioni;
- capacità di definire e di raggiungere obiettivi;
- capacità di autogestione;
- capacità di autosostegno;
- percezione di controllo e consapevolezza di sé.

In sintesi, le diverse definizioni di autodeterminazione che sono state fornite tendono a enfatizzare aspetti particolari, anche se assolutamente complementari, del costrutto. In generale si può dire che tutte convergono nell'individuare la finalizzazione adattiva, rappresentata dalla possibilità per la persona con disabilità di assumere nell'ambiente comunitario ruoli tipicamente

connessi con la situazione di adultità. Certamente le competenze personali e i deficit manifestati possono condizionare questa possibilità, ma per tutti si deve operare al fine di garantire buoni livelli di autodeterminazione, che non richiedono, come condizione di base, l'essere capaci di svolgere autonomamente tutte le attività.

Questa interpretazione del costrutto di autodeterminazione, come detto, porta in primo piano la dimensione educativa, finalizzata sia a favorire l'apprendimento di competenze specifiche, che a prevedere adeguati sostegni. Oltre ciò, le prospettive di autodeterminazione delle persone con disabilità sono inevitabilmente legate alle esperienze che si offrono loro per apprendere, praticare e perfezionare le abilità specifiche, sia in ambito familiare, che scolastico, che sociale. Gli sforzi per sostenere l'autodeterminazione devono essere accompagnati da opportunità frequenti, intenzionali e ben strutturate, affinché gli individui possano acquisire, mostrare, praticare e sviluppare, anche solo parzialmente, le abilità e i comportamenti adeguati. Questo orientamento educativo non può venire meno nel momento in cui ci si trova di fronte a situazioni molto complesse come la disabilità intellettiva grave o l'autismo, anzi deve addirittura intensificarsi.

Autodeterminazione e qualità della vita

Il concetto di *Qualità della vita* (QdV) può rappresentare un valido punto di riferimento per orientare e indirizzare i diversi contributi sull'autodeterminazione in una prospettiva pedagogica e didattica. In questo senso, infatti, la QdV può diventare al contempo sia l'obiettivo di qualsiasi intervento, che il parametro grazie al quale verificare l'efficacia e l'efficienza delle varie azioni che vengono messe in campo.

Chiaramente, il primo passo da compiere è quello di giungere a una definizione condivisa e operativa di QdV, altrimenti si corrono due rischi speculari: da un lato, quello di ridurre tale concetto a una dimensione unica e scarsamente rappresentativa della complessità del fenomeno, ad esempio identificandolo solamente con indicatori di salute fisica; dall'altro lato, quello di rendere il concetto di QdV talmente onnicomprensivo (includendo aspetti qualitativi e quantitativi e richiamandosi a termini diversi, quali benessere, felicità, ecc.) da renderlo difficilmente operazionalizzabile. Allo stato attuale, viene riconosciuta l'impossibilità di racchiudere il concetto di QdV all'interno di un costrutto monodimensionale; viceversa, sono necessari nuovi modelli, articolati su più dimensioni.

Senza
elaborati ne
(Cottini e F
Schalock e V
ai nostri fin
anche quell

Gli aut
definite con

1. benessere
2. relazioni
3. benessere
4. sviluppo
5. benessere
6. autode
7. inclusion
8. diritti.

Questi
il benessere
inclusione s
differenti si

1. il *microsi*
2. il *mesosist*
3. il *macrosi*

La figu

È evid
modo diver
a livello ind
serie di abili
sperimentat
sociali, potr
trario, a livel
inclusiva, m
volti a prom
rendendo p
si può nota
un'analisi d
contesto di

Senza analizzare le diverse interpretazioni e i vari modelli che sono stati elaborati negli ultimi tre decenni, per i quali rimando a un lavoro specifico (Cottini e Fedeli, 2008), mi soffermo sull'approccio euristico elaborato da Schalock e Verdugo Alonso (2002), il quale appare estremamente significativo ai nostri fini, in quanto, fra le varie dimensioni della QdV, enfatizza molto anche quella dell'autodeterminazione.

Gli autori propongono un modello centrato su otto dimensioni principali, definite come *domini*:

1. benessere emozionale;
2. relazioni interpersonali;
3. benessere materiale;
4. sviluppo personale;
5. benessere fisico;
6. autodeterminazione;
7. inclusione sociale;
8. diritti.

Questi domini fanno riferimento a condizioni soggettive (ad esempio il benessere emozionale) e oggettive (come i diritti individuali e il livello di inclusione sociale). La novità consiste nel modulare questi domini su tre differenti sistemi o contesti di vita:

1. il *microsistema*, attinente la crescita personale e le opportunità di sviluppo;
2. il *mesosistema*, ossia i programmi e le tecniche di miglioramento ambientale;
3. il *macrosistema*, relativo infine alle politiche sociali.

La figura 1.2 riporta l'articolazione del modello.

È evidente, infatti, che ciascun indicatore di QdV può svilupparsi in modo diverso, se non addirittura antitetico, nei tre sistemi. Ad esempio, se a livello individuale (*microsistema*) un individuo ha potuto sviluppare una serie di abilità di vita autonoma e integrata, grazie anche ai percorsi educativi sperimentati (*mesosistema*), il *macrosistema*, ossia l'insieme delle politiche sociali, potrebbe rivelarsi non in grado di supportare tale evoluzione. Al contrario, a livello *macro* potremmo avere politiche che enfatizzano la dimensione inclusiva, mentre a livello *meso* registrare una carenza di strumenti operativi volti a promuovere tale condizione per le persone con disabilità, ad esempio rendendo poco fruibili le opportunità ricreative offerte dalla comunità. Come si può notare, quindi, il modello di Schalock e Verdugo Alonso permette un'analisi della QdV attraverso il filtro delle politiche educative e sociali del contesto di vita (si veda figura 1.2).

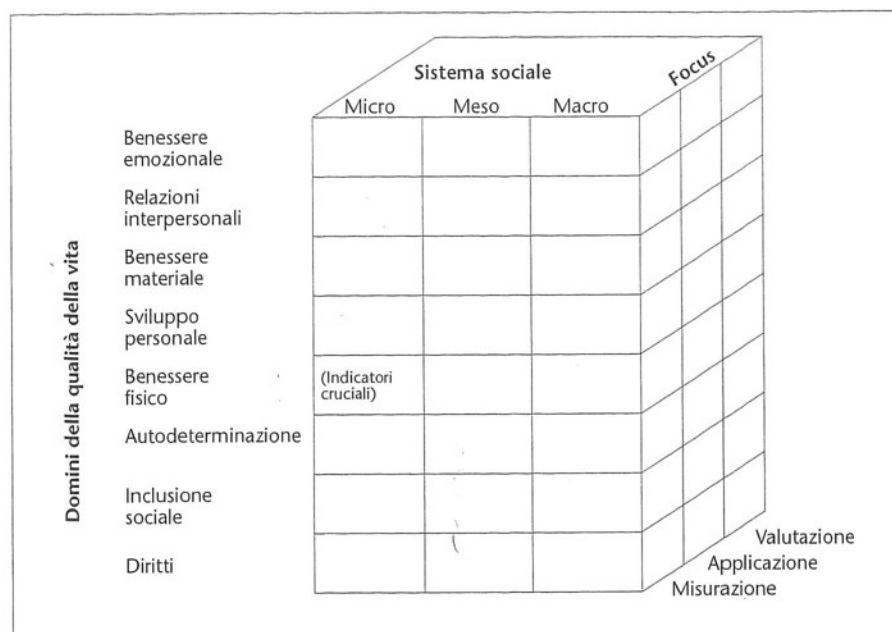


Fig. 1.2 Il modello euristico di Schalock e Verdugo Alonso (2002).

Andando più in profondità su queste dimensioni ecologiche, possiamo affermare quanto segue.

Il *microsistema* è strettamente collegato alla crescita personale e all'opportunità di sviluppo; attualmente sono quattro gli stimoli che più efficacemente agiscono a livello di microsistema per aumentare la qualità della vita percepita a livello personale. Il primo è il fattore appoggio per l'aumento delle opportunità di partecipare al processo complessivo della propria vita, tramite la promozione di inclusione sociale, equità, possibilità di scelta e autodeterminazione. Il secondo è la collaborazione tra persone e operatori per determinare l'importanza relativa o il valore dei domini centrali della QdV. Il terzo è il coinvolgimento sempre maggiore delle persone nella valutazione della propria qualità di vita. Il quarto, che punta allo sviluppo personale e all'incremento della formazione al benessere, sta divenendo una direttiva forte nei servizi e nell'erogazione dei sostegni.

Il *mesosistema* fa riferimento alle procedure di miglioramento dei contesti, rivolte sia agli ambienti di vita, che alla programmazione di servizi e sostegni adeguati. Le strategie su base ambientale coinvolgono la progettazione di spazi facilmente fruibili e la riduzione di eventuali ostacoli per l'interazione adeguata tra persona e ambiente. Le procedure di miglioramento centrate sui

progra
dei qu
sia la s
Il
tale liv
discre
norma
I
model
sperin
da Lac
perso
di cui
il rapp
risulta
tare co
rispett
(
educa
per le
adesso
cose pe
senso,
deterri
orient

Auto

(
situaz
distin
consi
mente
che ri
il qual
prend
biolog
coglie

programmi, invece, si riferiscono agli otto domini di base della QdV, ognuno dei quali risulta incrementabile attraverso politiche e pratiche che investono sia la sfera educativa, che quella più propriamente comunitaria.

Il *macrosistema* invece, fa riferimento alle politiche sociali, in particolare tale livello si riferisce al piano dei bisogni degli individui e alla potenziale discrepanza tra questi e ciò che effettivamente viene loro fornito a livello normativo e di servizi.

Le connessioni fra autodeterminazione e QdV, teorizzate con chiarezza nel modello di Schalock e Verdugo Alonso, sono state confermate anche a livello sperimentale. La ricerca più significativa, a questo proposito, è quella condotta da Lachapelle e colleghi (2005), i quali hanno studiato un ampio campione di persone con disabilità, anche se di non grave entità. L'obiettivo dell'indagine, di cui si dirà più nel dettaglio nel prossimo capitolo, era quello di evidenziare il rapporto tra autodeterminazione e QdV soggettivamente percepita, che è risultato significativamente correlato. Estremamente interessante è stato notare come i livelli di autodeterminazione siano risultati nettamente più bassi rispetto a quelli di QdV.

Questo ha portato Lachapelle e colleghi a sottolineare come le politiche educative e riabilitative si siano rivelate efficaci, negli ultimi anni, nel *fare cose per le persone disabili*, migliorando la loro qualità della vita; tuttavia, si tratta adesso di creare le condizioni di vita affinché le persone imparino a *fare le cose per se stesse*, mantenendo elevati livelli di autodeterminazione. In questo senso, allora, il potenziamento e/o il mantenimento di adeguati livelli di autodeterminazione costituisce un primo fondamentale obiettivo di un approccio orientato alla QdV.

Autodeterminazione, capability approach e disabilità

Come sottolineato in un recente lavoro (Cottini, 2014b), l'approccio alle situazioni di disabilità vede contrapporsi storicamente due modelli nettamente distinti: da un lato quello denominato *individuale* o *medico*, il quale tende a considerare la disabilità come un problema dell'individuo — causato direttamente da una condizione patologica legata a determinanti neurobiologiche —, che richiede un intervento specifico rivolto al deficit; dall'altro quello *sociale*, il quale sottolinea come sia la società a dover essere ridisegnata affinché possa prendere in considerazione i bisogni delle persone con disabilità: le limitazioni biologiche, infatti, diventano disabilità perché la società non è attrezzata per accogliere la differenza nei funzionamenti umani. Dall'approccio sociale deriva la

disciplina denominata *Disability Studies*, la quale mette in discussione l'assunto che lega causalmente l'avere una menomazione con l'essere disabile, proponendosi come obiettivo quello di promuovere il cambiamento della società.

Le dimensioni apparentemente inconciliabili di questi due modelli tendono a essere portate a sintesi dall'approccio che fa riferimento all'adozione del modello ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute; OMS, 2001) e da quello delle *capacità*, il quale enfatizza anche l'elemento della libertà di scelta dell'individuo, assolutamente centrale per la trattazione che stiamo sviluppando.

In concreto, in entrambi gli approcci vengono considerati due tipi di fattori alla base del funzionamento di ogni individuo: quelli personali, che corrispondono agli attributi caratteristici di ogni persona e quelli ambientali, che includono il contesto fisico e sociale e l'impatto dei comportamenti di ognuno. In questo modo si amplia la dimensione del modello individuale con una considerazione delle determinanti ambientali, le quali possono essere rappresentate da facilitatori o da barriere, anche se tale allargamento di prospettiva, almeno nella proposta ICF, viene ritenuto troppo timido per l'adeguata lettura della situazione da parte degli autori che si rifanno al paradigma dei *Disability Studies* (Medeghini et al, 2013).

Venendo all'analisi del modello delle capacità (*capability approach*), formulato a metà degli anni Ottanta dall'economista e filosofo Amartya Sen, bisogna sottolineare come esso sia stato promosso in numerosi ambiti, compresi quelli dello sviluppo umano, della qualità della vita e del rafforzamento della libertà in tutte le persone, anche in situazione di disabilità. Il concetto di riferimento è rappresentato da un'idea di qualità della vita, lo «star bene» (*well-being*) di Sen (1993), che dipende non tanto dai mezzi di cui ogni individuo può disporre, quanto piuttosto dalla capacità di trasformare tali disponibilità in concrete realizzazioni e risultati nella direzione che egli intende conseguire. In altre parole, è l'insieme di questi traguardi potenzialmente raggiungibili (spazio delle capacità o *capability set*) o effettivamente realizzati (spazio dei funzionamenti o *functioning*) che contribuisce, nel complesso, a determinare il benessere e la qualità della vita delle persone. L'enfasi viene posta sulla possibilità effettiva di scegliere quali azioni intraprendere, quali traguardi realizzare, quali piani di vita perseguire e in questa libertà risiede il concetto di giustizia (Sen, 2006; Nussbaum, 2007). Tale approccio è in grado di prendere in considerazione tutta l'ampia gamma di esperienze di disabilità, superando la limitata ottica basata sulla tipizzazione delle menomazioni.

La prospettiva del *capability approach* riesce così a tener conto dell'azione reciproca svolta dalle caratteristiche individuali e dalle restrizioni sociali

e propone di misurare i risultati in termini di espansione delle opportunità di scelta e quindi delle libertà delle persone (Biggeri e Bellanca, 2010). Il superamento della disabilità non coincide tanto con l'adeguamento a una «normalità», quanto piuttosto con l'ampliamento delle possibilità di scelta per l'individuo, con la promozione, in altre parole, della sua capacità di autodeterminazione.

Uno dei punti di forza di questo orientamento, estremamente significativo ai nostri fini, consiste nella centralità che viene attribuita all'individuo nella determinazione di quali sono le sue capability rilevanti. Sono le persone con disabilità stesse, quindi, ad avere il diritto di determinare cosa ritengono importante e significativo per la loro vita: anche se non sono completamente autonome nella realizzazione delle varie azioni, devono essere comunque gli agenti centrali delle decisioni che li riguardano e la qualità della loro vita valutata sulla base del grado di soddisfazione personale. Va messo in evidenza come questa impostazione, quando viene radicalizzata, esponga al rischio di vaghezza operativa e di eccessiva soggettivizzazione, con risultati non sempre positivi nel momento in cui ci si raffronta con la disabilità grave. Se prendiamo, ad esempio, il processo di deistituzionalizzazione e le procedure finalizzate all'inclusione sociale, ci sono studi che evidenziano come queste azioni non abbiano comportato un automatico miglioramento dello stato di benessere soggettivamente percepito, con le persone residenti da anni in condizioni compromesse che si manifestavano desiderose di rimanervi, mostrando talvolta livelli di benessere soggettivo assai elevati (Hatton e Emerson, 1996). È chiaro come in queste condizioni, senza un allargamento del capability set ricercato e promosso in tutto l'arco di vita della persona, si rischi che la focalizzazione esclusiva sul grado di soddisfazione personale porti a risultati apparentemente paradossali (Cottini e Fedeli, 2008).

Per ovviare a questa possibile deriva soggettivistica, Martha Nussbaum (2007) ha cercato di delineare un elenco di capability fondamentali, uguali per tutti gli esseri umani. Liste dedicate a singole categorie, infatti, creerebbero distinzioni e riporterebbero al centro il concetto di «normalità», con gravi ripercussioni sul piano dei diritti. Nussbaum afferma che tutti hanno diritto a poter svolgere le funzioni centrali della sua lista e che il compito del *policy maker* è quello di fare in modo che questo diritto venga garantito. Se qualcuno, che abbia o no una menomazione, non riesce a svolgere una di queste funzioni centrali al livello di soglia appropriato, la società deve fare il possibile affinché egli possa farlo (Bellanca, Biggeri e Marchetta, 2010). Riguardo alle persone in situazione di disabilità, quindi, bisogna chiedersi cosa esse siano effettivamente in grado di fare e di essere e quali siano gli ostacoli da superare,

per fare in modo che possano esercitare le loro abilità fino al livello di soglia appropriato, nella direzione da loro scelta.

La dimensione dell'autodeterminazione è ancora in primo piano: infatti, valutare le capacità e le *performance* che un individuo ha nel fare una particolare attività, senza chiedersi se egli sia interessato a praticarla, significa non tener conto di uno dei diritti essenziali delle persone, ossia quello di scegliere liberamente della propria esistenza (Morris, 2009).

Auto

Nel
costituisc
di ogni pe
entro mag
ficativi rif
intellettiv
della lette
troppo nu
di applica

La ra
di base pe
strument
piste dida
mettere in

Autodete

Esist
derazione
persone i
principal